

PDF ANONIMIZADO

ID publico: case_0328

Paginas del documento: 7

Copia anonimizada para verificacion metodologica.

Se removieron portada editorial, titulo, autores, afiliaciones, correos, DOI, URLs y metadatos del PDF original.

Las paginas restantes conservan el contenido util para revisar metodos, resultados, tablas y conclusiones.

Nota: la anonimización automatica prioriza reducir la identificacion directa del articulo. Los casos de una sola pagina o diseno no convencional deben revisarse manualmente antes de una publicacion abierta.

Dentro de los factores de riesgo evidenciados en estudios epidemiológicos, se los ha clasificado en factores modificables y no modificables. Dentro de los no modificables; se encuentran principalmente la edad, el sexo y la raza. En los modificables se encuentran, hipertensión arterial, tabaquismo, diabetes, dislipidemia y cardiopatías. Se han realizado múltiples estudios donde se investiga la relación entre el ACV con la edad del paciente, uno de ellos determinó que en aquellos pacientes de 41 a 50 años se encontraron 1.97% con ACV, de 51 a 60 años un 30.65%, de 61 a 70 años un 22.61% y finalmente de 71 a 80 años hubo una prevalencia de 29.74%, concluyendo en que existe una mayor prevalencia entre los 50 a 60 años. La estrecha relación entre accidente cerebrovascular y la edad se debe a que mientras mayor es la edad del paciente, existe mayor probabilidad de que padezca comorbilidades que provoquen acumulación de placas en las arterias, rigidez de las paredes de los vasos sanguíneos, hipertensión arterial, entre otras. El sexo también es un factor por tomar en cuenta, debido a que los niveles de estrógeno altos ofrecen protección cardiovascular, lo cual podría ser el motivo para que, en edad menopáusica, las mujeres presenten un aumento en su tendencia a presentar un ACV y que los hombres estén siempre con mayor probabilidad de afectación [3, 4].

De igual forma, en otro estudio en base a la edad de presentación del ACV, se determinó que la población más vulnerable fueron los hombres con una frecuencia de 59%,

brovascular, en contraposición a la frecuencia que se presentaba en edades más jóvenes [5].

Las manifestaciones clínicas que puede presentar los pacientes dependerán de la topografía de la lesión, la cual es determinada por las áreas de irrigación de las principales arterias cerebrales. En una investigación se identificó la arteria cerebral media como la más afectada con un 57.3% de los casos, siguiéndole la arteria cerebral posterior con 26.7%. Respecto a los signos y síntomas, se determina a la hemiparesia como el signo más común tanto en ACV isquémico como en el hemorrágico, continuando con la parálisis facial periférica, la disartria, la cefalea, ataxia y finalmente, afasia [6].

La morbimortalidad del accidente cerebrovascular causa un gran impacto a la sociedad, por lo cual resulta imprescindible abordar el tema realizando un estudio que permita dimensionar la frecuencia con la que ACV se presenta en pacientes con edades entre 50-80 años, con el propósito de determinar la vulnerabilidad de este grupo etario y tomarla en consideración en nuevos pacientes para prevenir esta manifestación. Por el presente motivo, se escogió un Hospital de tercer nivel de referencia regional para determinar la prevalencia de accidente cerebrovascular en pacientes entre 50 a 80 años de edad.

Materiales y métodos

Diseño del estudio

El presente estudio es observacional. La fuente es retrospectiva.

Escenario

El estudio se desarrolló el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, localizado en la ciudad de Guayaquil de la provincia del Guayas, durante enero del 2021 a diciembre del 2022.

Participantes

Se incluyeron pacientes de 50 a 80 años de edad, con el diagnóstico de accidente cerebro vascular de reciente diagnóstico atendidos en el servicio de emergencia de la institución. No se excluyeron pacientes.

Variables

Las variables fueron: edad, sexo, presencia de comorbilidades: hipertensión arterial, fibrilación auricular, diabetes mellitus tipo 2, obesidad. Topografía de la lesión. Presencia de síntomas: cefalea, náusea, hemiplejía,

iones

lenó un formulario electrónico a la historia clínica electrónica institucional AS400. Se realizó una pesquiza de los siguientes códigos raíces CIE-10 para inclusión en el estudio: I62-169. Para la clasificación de la hipertensión arterial se utilizó la normativa ESC/ESH de la Sociedad Europea de Hipertensión (ESH) y la European Society of Cardiology (ESC).

Sesgos

Se evitó el sesgo de observación y selección aplicando los criterios de selección de participantes. Para evitar posibles sesgos de entrevistador, de información y de memoria, el investigador principal mantuvo en todo momento los datos con una guía y registros aprobados en el protocolo de investigación. Dos investigadores analizaron de forma independiente cada registro por duplicado y las variables fueron registradas en la base de datos una vez verificada su concordancia.

Tamaño del estudio

La muestra fue probabilística. En una población entre 50 a 80 años en Guayaquil de 516,282 habitantes, la prevalencia de accidentes cerebrovasculares es de 200 casos por 100,000 habitantes, lo que representa 1032 casos posibles. Usando EPI info™ (Stat Calc, Epi Info, CDC, Atlanta. Versión 7.2.6 [octubre,2023]); con una frecuencia esperada del 15%, con un límite de confianza del 5% y un nivel de confianza del 95% el tamaño muestral fue de 165 casos.

Variables cuantitativas

Se utilizó estadística descriptiva. Los resultados se expresan como frecuencia y porcentaje. No se convirtieron variables en escala a categóricas.

Análisis estadístico

Las variables cualitativas fueron analizadas con frecuencia y porcentajes. Las proporciones se comparan con Chi cuadrado. El paquete estadístico utilizado fue IBM Corp. Released 2018. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 26.0. Armonk, NY: IBM Corp.

Fueron ingresados al estudio 175 casos.

Características principales del grupo de estudio

Fueron 175 pacientes. La edad promedio fue de 65.77 años ± 8.29. En relación al grupo etario más afectado el primer rango definido de 50 a 59 años tuvo un resultado del 26.3% (n=46), el segundo rango de 60 a 69 años obtuvo el 32% (n=56) y el último rango de 70 a 80 años, representó el 41.7% (n=73) de los casos. La población masculina representó el 62.9% (n= 110), mientras que la femenina un 37.1% (n=65).

Respecto a las manifestaciones clínicas se obtuvieron los siguientes resultados, la hemiparesia se presentó en el 73,1% (n= 128), disartria 60% (n=105), asimetría facial 44% (n=77), cefalea 43.4% (n=76), afasia 37.7% (n=66), náuseas 33,7% (n= 59), hipoestesia 30.9% (n=54), hemiplejía 29.1% (n=51), parestesia 20,6% (n= 36) y finalmente ataxia en 16.6% (n=29) (Tabla 1).

Tabla 1. Características principales del grupo de estudio.

Variables	Promedio ± DE
Edad	65.77 ± 8.29
Por grupo etario	n (%)
50 a 59 años	46 (26.3 %)
60 a 69 años	56 (32.0 %)
70 – 80 años	73 (41.7 %)
Sexo	n (%)
Hombre	110 (62.9 %)
Mujer	65 (37.1 %)
Manifestaciones clínicas	n (%)
Hemiparesia	128 (73.1 %)
Disartria	105 (60.0 %)
Asimetría facial	77 (44.0 %)
Cefalea	76 (43.4 %)
Afasia	66 (37.7 %)
Nauseas	59 (33.7 %)
Hipoestesia	54 (30.9 %)
Hemiplejía	51 (29.1 %)
Parestesia	36 (20.6 %)
Ataxia	29 (16.6 %)

Frecuencia de los factores de riesgo

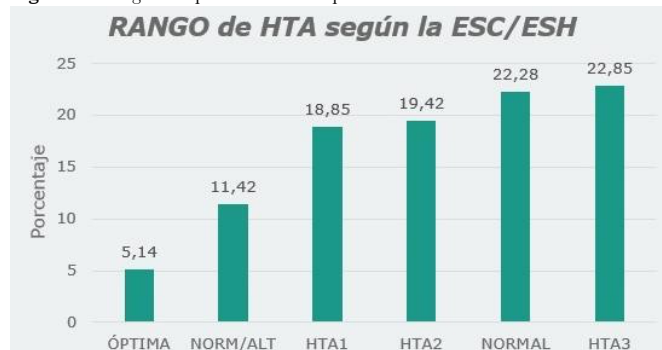
En cuanto a los factores de riesgo, se evidenció que el 82.90% (n=145) de la muestra padecía de hipertensión arterial, la manifestación de diabetes fue del 41.1% (n=72), obesidad un 38.9% (n=68), dislipidemia con 37.7% (n=66), ACV previo se presentó en el 32% (n=56), el hábito de tabaquismo se encontró en el 12.6% (n=22) y finalmente, solo el 10.9% (n=19) contaba con antecedente de fibrilación auricular (Tabla 2).

n= 33), HTA grado 2 en 19.42%
2.85% (n=40) (Figura 1).

Tabla 2. Frecuencia de los principales factores de riesgo.

Factores de riesgo	N	%
Hipertensión arterial	145	82.90%
Diabetes Mellitus	72	41.10%
Obesidad	68	38.90%
Dislipidemia	66	37.7%
ACV Previo	56	32.0%
Consumo de tabaco	22	12.60%
Fibrilación auricular	19	10.90%

Figura 1. Rango de hipertensión en los pacientes con accidente cerebral vascular.



ESC/ESH: Sociedad Europea de Hipertensión (ESH) y la European Society of Cardiology (ESC).

Tipos de accidente cerebrovascular

El tipo de accidente cerebrovascular más prevalente fue de origen isquémico afectando a un 64% (n=112) de los pacientes y un 36% (n=63) fue hemorrágico. Dentro de los pacientes con diagnóstico de ACV isquémico, la puntuación del NIHSS en la categoría de ACV leve fue del 16.96% (n=19), en ACV moderado del 68.75% (n= 77), ACV moderado a severo fue del 11.61% (n=13) y ACV severo fue del 2.68% (n=3) (Figura 4). En cuanto a la topografía de la lesión, utilizando las principales arterias cerebrales, se obtuvieron los siguientes resultados; ACM un 62.8% (n=110), la ACP un 19.51% (n=34), ACA un 14.27% (n=25) y finalmente la arteria basilar un 3.42% (n=6) (Figura 2). Según el grado de accidente cerebro vascular, el grado moderado fue el más prevalente (Figura 3) y la arteria cerebral media fue la más afectada (Figura 4).

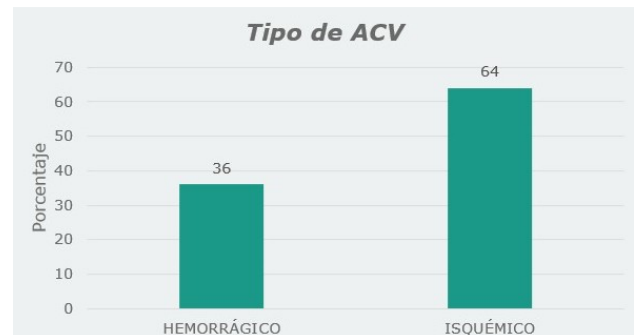


Figura 3. Grado de accidente cerebro vascular.

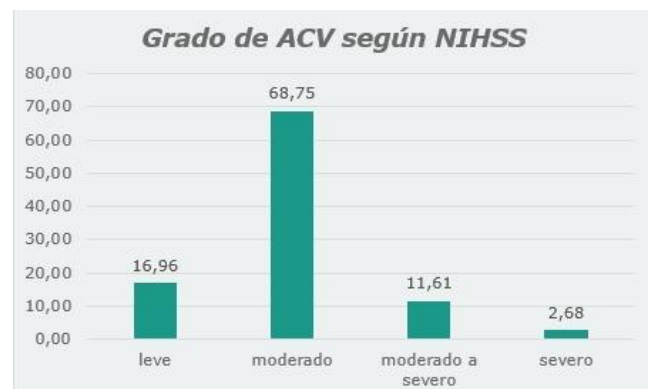
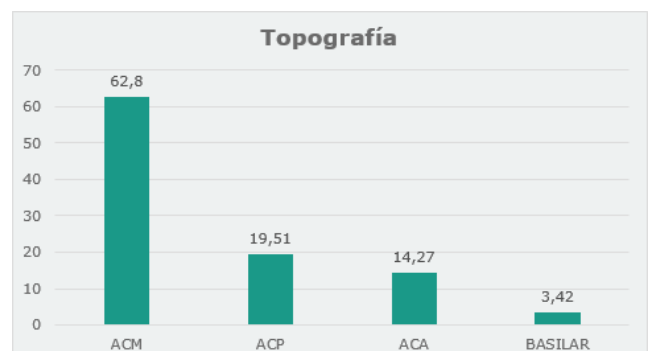


Figura 4. Topografía de la lesión del accidente cerebro vascular.



ACM: arteria cerebral media. ACP: arteria cerebral posterior. ACA: Arteria cerebral anterior.

das con el accidente cerebrovascular, en el presente estudio se en-
io fue de 65 años y el rango de
edad más vulnerable fue el de 70 a 80 años con un 41.7%, lo
cual se contrasta con el estudio realizado por Berna KP., cuyo
promedio de edad fue de 60 años, y el rango edad más afectado
fue de 51 a 60 años con un 30.65%. Respecto al sexo de
los pacientes, ambos estudios guardaron relación, presen-
tando una mayor prevalencia del sexo masculino con 62.9%
y 71.85% respectivamente [3].

En cuanto a los hallazgos imagenológicos y topográficos,
de Oliveira AJ concluye en que el tipo de accidente cerebro-
vascular más frecuente es el isquémico, con un 56%, y deter-
mina a la arteria cerebral media como la más afectada con un
57.3%. Este estudio concluye al ACV isquémico como más
frecuente con un 64% y a la arteria cerebral media con un
62.8%, lo cual se correlaciona con las bibliografías internacio-
nales que sitúan al accidente cerebrovascular isquémico con
una frecuencia del 80% de los casos [6, 7].

Mendoza CR, determinó que los factores de riesgo más
frecuentes fueron hipertensión arterial con un 61.3%, insufi-
ciencia cardíaca un 56.2% y fibrilación auricular un 41.2%.
En este estudio se identificó a hipertensión arterial con un
82.90%, diabetes mellitus un 41.1% y fibrilación auricular un
10.9%. La discrepancia en datos de la fibrilación auricular
puede deberse a un diagnóstico insuficiente al momento del
ingreso, o por limitaciones propias del estudio transversal en
el cual no se recolectó futuros diagnósticos de la historia clínica [8].

En relación a la clínica del accidente cerebrovascular,
Vera DE estableció a la cefalea con un 99% y parestesia un
87% como las manifestaciones clínicas de mayor impacto. En
la presente investigación se concluyó a la hemiparesia con un
73.1% y la disartria 60% [9].

Es importante tener en cuenta que la enfermedad renal
crónica, la anemia y el ACV a menudo comparten factores de
riesgo comunes, como la diabetes y la hipertensión [10-13].
La anemia en la enfermedad renal crónica puede exacerbar
los efectos de otros factores de riesgo cardiovascular, aumen-
tando aún más el riesgo de ACV, aunque en el presente estu-
dio no se determinó la presencia de enfermedad renal sería
una línea de investigación a futuro.

ACV en pacientes entre 50 a 80 años de edad del servicio de
emergencia del HTMC durante el 2021-2022 fue de 317 pa-
cientes. Respecto a las características epidemiológicas, se ob-
servó una tendencia creciente de ACV a medida que aumenta
la edad del paciente, siendo el grupo etario más afectado pa-
cientes entre 70 a 80 años. Demográficamente, el sexo mas-
culino tuvo una mayor inclinación a esta patología en compa-
ración al sexo femenino. En cuanto a las manifestaciones clí-
nicas, este estudio concluyó en que la hemiparesia, disartria y
asimetría facial fueron los síntomas cardinales. En relación a
los factores de riesgo que se encontraron con mayor frecuen-
cia en pacientes con accidente cerebrovascular, se identifica-
ron a la hipertensión arterial, la diabetes y obesidad como las
principales comorbilidades. El accidente cerebrovascular que
se encontró con mayor frecuencia fue el de origen isquémico,
afectando principalmente a la arteria cerebral media y cau-
sando un déficit neurológico moderado en la mayoría de los
pacientes.

Referencias

1. Hankey GJ. Stroke. *Lancet*. 2017 Feb 11;389(10069):641-654.
2. Feske SK. Ischemic Stroke. *Am J Med*. 2021 Dec;134(12):1457-
3. George MG, Tong X, Bowman BA. Prevalence of Cardiovascu-
4. Wan S, Dandu C, Han G, Guo Y, Ding Y, Song H, Meng R.
5. Schäfer A, Flierl U, Berliner D, Bauersachs J. Anticoagulants for
6. Lopes RP, Gagliardi VDB, Pacheco FT, Gagliardi RJ. Ischemic
stroke with unknown onset of symptoms: current scenario and
perspectives for the future. *Arq Neuropsiquiatr*. 2022

n S. Diagnosis and Management of

8. Gidey K, Hailu A. A Prospective Study of Stroke Characteristics,

9. Garza-Alatorre G, Carrion-Garcia AL, Falcon-Delgado A,

10. Abril J, Sanchez J. Características de la enfermedad renal crónica en el Ecuador desde el año 2009 hasta el año 2012. [Tesis] Universidad de Cuenca, Ecuador: 2014. [dspace](#)

11. Mora-Bravo FG, Torres PTM, Campoverde NR, Carcelen

12. Rivera-González SC, Pérez-Grovas H, Madero M, Saavedra N,

13. Mora-Bravo F, Muñoz J. Impaired Reconversion of Bone Ma-

estudio.

Contribuciones de los autores

María Valeria Aragundi Palacios: Conceptualización, Investigación, Redacción – borrador original, Recursos, Software, Supervisión.

John Henry Tenorio Castillo: Conceptualización, Investigación, Redacción – borrador original, Recursos, Software, Supervisión.

Sunny Eunice Sánchez Giler: Metodología, Curación de datos, Análisis formal, Adquisición de fondos, Administración del proyecto, Validación, Visualización, Redacción – revisión y edición.

Todos los autores leyeron y aprobaron la versión final del manuscrito.

Financiamiento

Los autores financiaron los gastos de esta investigación.

Disponibilidad de datos y materiales

Los conjuntos de datos utilizados y analizados durante el presente estudio es-

Declaraciones

Aprobación de comité de ética y consentimiento para participar

El estudio fue aprobado por el comité de bioética de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador.

Consentimiento de publicación

No fue requerido debido a que el presente estudio no publica imágenes, radiografías y estudios específicos de pacientes.

Conflictos de interés

La investigación no tiene intereses financieros ni conflictos de intereses.

Información de los autores

ORCID

ORCID

Abreviaturas

ACV: Accidente cerebro vascular.

HTA: Hipertensión arterial.

Información suplementaria

No se declara materiales suplementarios.

Nota del Editor

Aragundi M, Tenorio J, Sánchez S. Prevalencia de accidente cerebrovascular en pacientes entre 50 - 80 años de edad atendidos en emergencia. Un estudio observacional de centro único. Actas Médicas (Ecuador) 2025;35(1):20-26.

© **Copyright 2025**, María Valeria Aragundi Palacios, John Henry Tenorio Castillo, Sunny Eunice Sánchez Giler.

Dirección: Avenida Carlos Julio Arosemena Km 1/2 Vía a Daule, Facultad de Medicina, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Guayaquil, Guayas, Ecuador.

Teléfono: [593] 990994445.
